

ROUGEOLE



Virus de la rougeole



INCUBATION: 8 à 10 jours



Hiver et printemps



Nourrissons et adolescents



CONTAGIOSITÉ: durant les 5 jours précédant et suivant le début de l'éruption



ÉVICTION SCOLAIRE d'au moins 4 jours après le début de l'éruption



- Malaise général, abattement
- Irritabilité
- Fièvre élevée
- Rhinorrhée, toux



Yeux rouges



SIGNE PARTICULIER. Taches de Koplik



NE PAS CONFONDRE AVEC : maladie de Kawasaki, scarlatine, autre éruption virale, toxidermie, allergie



ÉVOLUTION. Guérison en une dizaine de jours



COMPLICATIONS: otite, convulsion, diarrhée, pneumonie, laryngo-trachéo-bronchite, encéphalite, ~~pan~~encéphalite sclérosante subaiguë



FACTEURS DE RISQUE : premiers 12 mois de vie, déficits immunitaires, malnutrition, grossesse



RISQUE EMBRYO-FOETAL. Faible risque de maladie congénitale



ÉRUPTION MACULO-PAPULEUSE

- Rash généralisé non prurigineux débutant au niveau de la tête puis envahissant le tronc et les membres.
- Éléments maculo-papuleux rouges espacés de peau saine.
- Érythème des muqueuses bucco-pharyngées; dépôts blanchâtres à la face interne des joues (taches de Koplik).



TRAITEMENT symptomatique; vitamine A si facteur de risque



PRÉVENTION.

Contacts réceptifs : gammaglobulines IV
Entourage: vaccination des sujets réceptifs



RUBÉOLE



Virus de la rubéole



INCUBATION: 14 à 21 jours



Hiver, printemps



Surtout nourrissons et adolescents



CONTAGIOSITÉ: les 7 jours avant et après le début de l'éruption
(Pendant plusieurs mois pour la rubéole congénitale)



ÉVICTION SCOLAIRE 1 semaine
(période contagieuse)



- Bon état général
- Pas ou peu de fièvre
- Adénopathies sous-occipitales et rétro-auriculaires
- Arthralgies distales (adolescents, adultes)



Conjonctives normales



SIGNE PARTICULIER. Risque tératogène



NE PAS CONFONDRE AVEC :
autre exanthème viral, scarlatine, allergie



ÉVOLUTION. Guérison rapide de la forme acquise



COMPLICATIONS inhabituelles:
encéphalite, purpura, anémie
hémolytique, myocardite, péricardite



FACTEURS DE RISQUE :
grossesse



RISQUE EMBRYO-FOETAL.
Risque d'embryopathie-
foetopathie tératogène



ÉRUPTION MACULO-PAPULEUSE

- Éruption non prurigineuse du visage puis du tronc et des membres
- Macules rouges ou rosées, espacées de peau saine, plus vives et plus denses sur les joues, plus clairsemées sur le tronc et les membres
- Pas d'atteinte des muqueuses



TRAITEMENT symptomatique



PRÉVENTION.

Contacts normaux : surveillance
Femmes enceintes : vérification du statut
sérologique, gammaglobulines IM (?)



SCARLATINE



Streptocoque  -hémolytique du groupe A



INCUBATION: 2 à 5 jours



Toutes saisons



Surtout âge scolaire



CONTAGIOSITÉ: maximale au stade aigu; pendant plusieurs jours ou semaines en l'absence de traitement



ÉVICTION SCOLAIRE jusqu'au rétablissement de l'enfant; plus de risque contagieux après 24 heures d'antibiothérapie



- État général ☒ bon
- Fièvre
- Mal de gorge, dysphagie
- Douleurs abdominales
- Nausées, vomissements
- Adénopathies cervicales



Conjonctives normales



SIGNE PARTICULIER. Signe de Pastia, langue framboisée



NE PAS CONFONDRE avec : dermite de contact, maladie de Kawasaki, allergie, rougeole



ÉVOLUTION. Guérison rapide sous antibiothérapie



COMPLICATIONS: abcès péri-amygdalien, rhumatisme articulaire aigu, glomérulonéphrite aiguë



FACTEURS DE RISQUE : antécédents de rhumatisme articulaire aigu, de glomérulonéphrite aiguë



RISQUE EMBRYO-FOETAL négligeable



ÉRUPTION ÉRYTHÉMATEUSE



- Éruption généralisée prédominant au niveau de la face antérieure du tronc.
- Pâleur du pourtour de la bouche et du nez si érythème du visage.
- Peau rouge et rêche; éruption plus foncée au niveau des plis de flexion (signe de Pastia).
- Amygdales rouges et exsudatives, pétéchies au niveau du palais, langue saburrale puis rouge framboise.



TRAITEMENT antibiothérapie orale



PRÉVENTION.

Contacts normaux : surveiller

Contacts à risque: culture de gorge

ÉXANTHÈME LATÉRO-THORACIQUE



Cause virale probable



INCUBATION: durée variable selon étiologie



Surtout le printemps



Âge préscolaire



CONTAGIOSITÉ: peu contagieux



ÉVICTION SCOLAIRE indiquée ou non selon contexte clinique



- Bon état général
- Pas ou peu de fièvre
- Adénopathie (aisselle, aine)
- Prurit absent ou modéré



Conjonctives normales



SIGNE PARTICULIER. Distribution des lésions (régions latéro-thoraciques)



NE PAS CONFONDRE AVEC : dermite de contact, eczéma, scarlatine



ÉVOLUTION. Guérison spontanée en 2 à 8 semaines



COMPLICATIONS: maladie bénigne



FACTEURS DE RISQUE : ?



RISQUE EMBRYO-FOETAL négligeable



ÉRUPTION PAPULO-VÉSICULEUSE

- Éruption tronculaire asymétrique de petites papules rouges ou rosées formant des placards érythémateux eczématoïforme ou scarlatiniforme.
- Éruption débutant au niveau d'une région sous-axillaire puis se propageant vers le bras et, au travers du thorax, vers l'autre région sous-axillaire et, le long du flanc abdominal, vers la région inguinale; elle prédomine du côté où elle débute.
- Pas d'atteinte muqueuse.



TRAITEMENT symptomatique



PRÉVENTION.
Informier et rassurer



Virus de la Rubéole



INCUBATION : 14 à 21 jours



Hivers et printemps



Surtout nourrissons et adolescents



Contagiosité : les 7 jours avant et après le début de l'éruption (Pendant plusieurs mois pour la rubéole congénitale)



EVICITION SCOLAIRE
1 semaine (période contagieuse)



- Bon état général
- Pas ou peu de fièvre
- Adénopathies sous-occipitales et rétro-auriculaires
- Arthralgies distales (adolescents, adultes)



Conjonctives normales

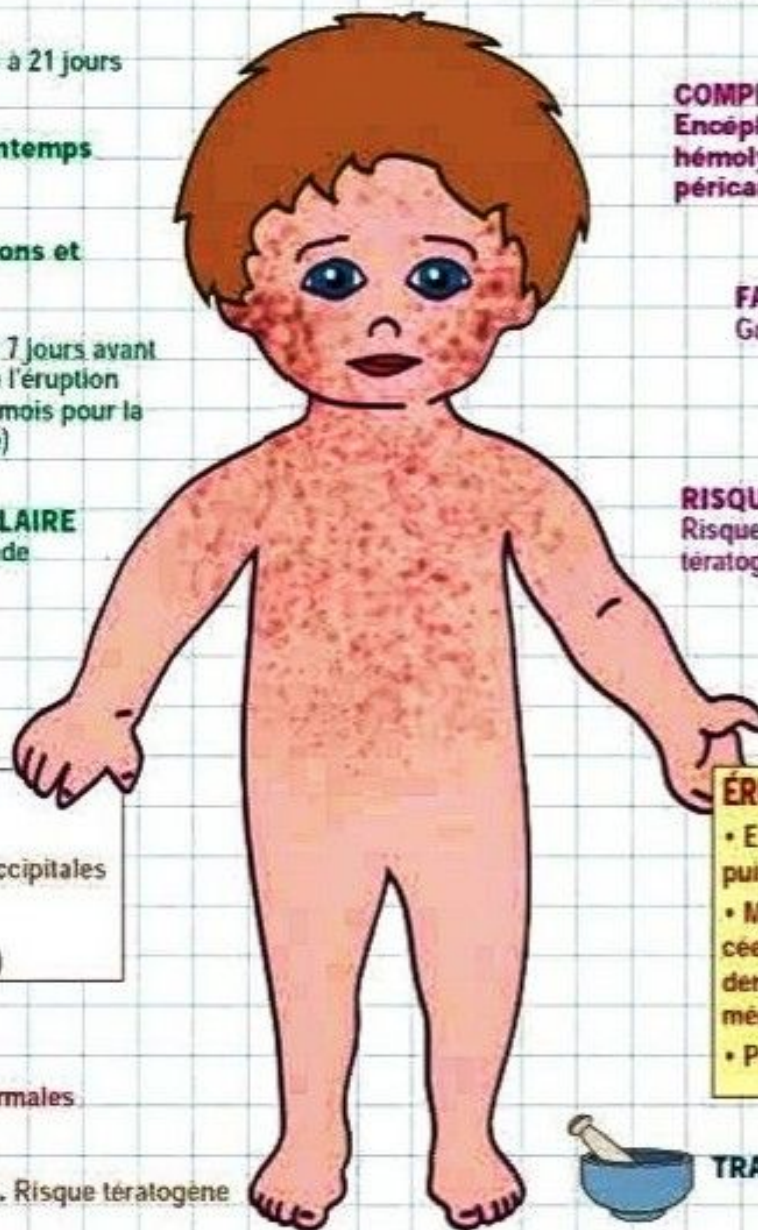


SIGNE PARTICULIER. Risque tératogène



NE PAS CONFONDRE AVEC :
autre exanthème viral, scarlatine, allergie.

La Rubéole



ÉVOLUTION. Guérison rapide de la forme acquise.



COMPLICATIONS inhabituelles:
Encéphalite, purpura, anémie hémolytique, myocardite, péricardite.



FACTEURS DE RISQUE :
Grossesse.



RISQUE EMBRYO-FŒTAL.
Risque d'embryopathie-fœtopathie tératogène.



ÉRUPTION MACULO-PAPULEUSE

- Eruption non prurigineuse du visage puis du tronc et des membres.
- Macules rouges ou rosées, espacées de peau saine, plus vives et plus denses sur les joues, plus clairsemées sur le tronc et les membres.
- Pas d'atteinte des muqueuses.



TRAITEMENT. symptomatique.



PRÉVENTION :

Contacts normaux : surveillance
Femme enceinte : vérification du statut sérologique, gammaglobulines IM (?)



MALADIE DE KAWASAKI



Cause inconnue



INCUBATION: durée inconnue



Toutes saisons



Âge préscolaire



CONTAGIOSITÉ: maladie très peu contagieuse



ÉVICTION SCOLAIRE jusqu'à rétablissement de l'enfant



Fièvre élevée

- Irritabilité
- Adénopathie cervicale
- Douleurs abdominales, diarrhée, vomissements



Yeux rouges



SIGNE PARTICULIER. Danger cardiaque



NE PAS CONFONDRE AVEC :

scarlatine, rougeole, exanthème viral non spécifique, arthrite rhumatoïde, choc toxique, syndrome de Stevens-Johnson



ÉVOLUTION. Le plus souvent guérison complète; parfois séquelles cardiaques



COMPLICATIONS: anévrismes coronariens, infarctus myocardique



FACTEURS DE RISQUE : race jaune, sexe masculin, âge ☒ an, fièvre ☒ jours
anémie, hypoalbuminémie



RISQUE EMBRYO-FOETAL négligeable (?)



ÉRUPTION VÉSICULEUSE

- Rash généralisé polymorphe (le plus souvent aspect maculo-papuleux, morbilliforme ou scarlatiniforme et localisation tronculaire).
- Rougeur et gonflement des mains et des pieds.
- Secondairement desquamation péri-unguéal et palmo-plantaire.
- Anomalies bucco-labiales (érythème buccal et pharyngé, langue framboisée, lèvres rouges et fissurées).



TRAITEMENT ☒ H gammaglobulines immunes en perfusion iv et aspirine



PRÉVENTION.
Surveillance



ROSÉOLE



Virus herpétique humain type 6 ou 7



INCUBATION: 5 à 15 jours



Toutes saisons



Surtout entre 6 et 24 mois



CONTAGIOSITÉ: pendant la phase fébrile



ÉVICTION SCOLAIRE: surveillance à domicile de l'enfant fébrile



- État général plutôt bon
- Forte fièvre
- Irritabilité
- Tympan congestifs



Conjonctives normales



SIGNE PARTICULIER. Fièvre de 3 jours puis éruption



NE PAS CONFONDRE AVEC : autre exanthème virale (entérovirus, rubéole, rougeole), rash allergique



ÉVOLUTION. Guérison habituelle complète en moins d'une semaine



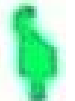
COMPLICATION: convulsion fébrile, hypertension intracrânienne bénigne, méningo-encéphalite



FACTEURS DE RISQUE: transplantation, déficit immunitaire



RISQUE EMBRYO-FOETAL négligeable



ÉRUPTION MACULO-PAPULEUSE



- Maculo-papules rosées se localisant préférentiellement au niveau du tronc (surtout abdomen et région lombaire) et du visage (front).
- Éruption apparaissant dans les 24 à 48 heures qui suivent le retour de la température à la normale et disparaissant en moins de 3 jours, sans desquamation, ni pigmentation.
- Parfois présence de petites lésions maculo-papuleuses au niveau du palais mou (taches de Nagayama).



TRAITEMENT symptomatique



PRÉVENTION. Soins d'hygiène habituels

VARICELLE



Virus varicelle-zona



INCUBATION: + 15 jours. Après immunoglobulines: jusqu'à 20 jours



Toutes saisons



Surtout âge scolaire



CONTAGIOSITÉ: 5 jours avant l'éruption et jusqu'à l'assèchement des lésions



ÉVICTION SCOLAIRE indiquée ou non selon contexte clinique



- État général plutôt bon
- Fièvre modérée
- Prurit cutané



Conjonctives normales



SIGNE PARTICULIER. Vésicules et prurit



NE PAS CONFONDRE AVEC : piqûres d'insecte, maladie de Gianotti-Crosti, molluscum contagiosum, herpès cutané, folliculite, maladie mains-pieds-bouche



ÉVOLUTION. Guérison habituelle en + 1 semaine



COMPLICATIONS: impétigo, cellulite, fasciite, pneumonie, hépatite ataxie, encéphalite, syndrome de Reye



FACTEURS DE RISQUE : période néonatale, prématurité, âge adulte, déficits immunitaires, aspirine



RISQUE EMBRYO-FOETAL. Faible risque d'embryopathie



ÉRUPTION VÉSICULEUSE

- Rash photosensible généralisé à prédominance tronculaire .
- Lésions maculo-papuleuses puis vésiculeuses et croûteuses.
- Éléments d'âge et d'aspect différents dans un même territoire
- Cicatrices hypopigmentées ou hyperpigmentées
- Vésicules ou lésions érosives sur les muqueuses buccale et génitale



TRAITEMENT symptomatique: **ecyclex** si facteur de risque



PRÉVENTION.

Contacts normaux: surveillance
Contacts à risque: immunoglobulines de varicelle-zona (VZIG)



MALADIE "MAINS-PIEDS-BOUCHE"



Virus coxsackie A 16



INCUBATION: 3 à 6 jours



Printemps et été



Âges préscolaire et scolaire



CONTAGIOSITÉ: pendant les 7 jours suivant le début du rash



ÉVICTION SCOLAIRE au besoin (selon état clinique)



- Bon état général
- Pas ou peu de fièvre
- Dysphagie, anorexie



Conjonctives normales



SIGNE PARTICULIER. Distribution des lésions



NE PAS CONFONDRE AVEC : varicelle, stomatite herpétique, herpès



ÉVOLUTION. Guérison spontanée en près d'une semaine



COMPLICATIONS inhabituelles: déshydratation, myocardite, méningo-encéphalite



FACTEURS DE RISQUE : absence apparente



RISQUE EMBRYO-FOETAL négligeable



ÉRUPTION VÉSICULEUSE

- Vésicules à contenu clair ou citrin cernées d'un liseré rouge ou maculo-papules situées au niveau des mains et des pieds
- Lésions maculo-papuleuses au niveau des fesses et sur le haut des cuisses
- Parfois éléments papulo-vésiculeux au niveau du tronc et des membres
- Chez la fille, présence possible de lésions vésiculeuses au niveau des régions inguinales et vulvo-périnéale
- Lésions aphteuses au niveau des muqueuses buccales et sur les lèvres
- Pas d'atteinte des muqueuses conjonctivales



TRAITEMENT symptomatique



PRÉVENTION.
Informez et rassurez
Conseils d'hygiène

Méningite du nourrisson

Vigilance !

Est-ce que l'état de votre bébé s'aggrave rapidement ?
Les bébés peuvent tomber malades très rapidement, aussi examinez-le souvent

Fontanelle
bombée ou tendue

Température
élevée

Traits endormis
Expression figée

Vomissements/Refus du biberon
Irritable quand pris dans les bras
cri violent ou plaintif

Respiration rapide
Difficulté à respirer

Peau marbrée, devenant pâle ou bleue

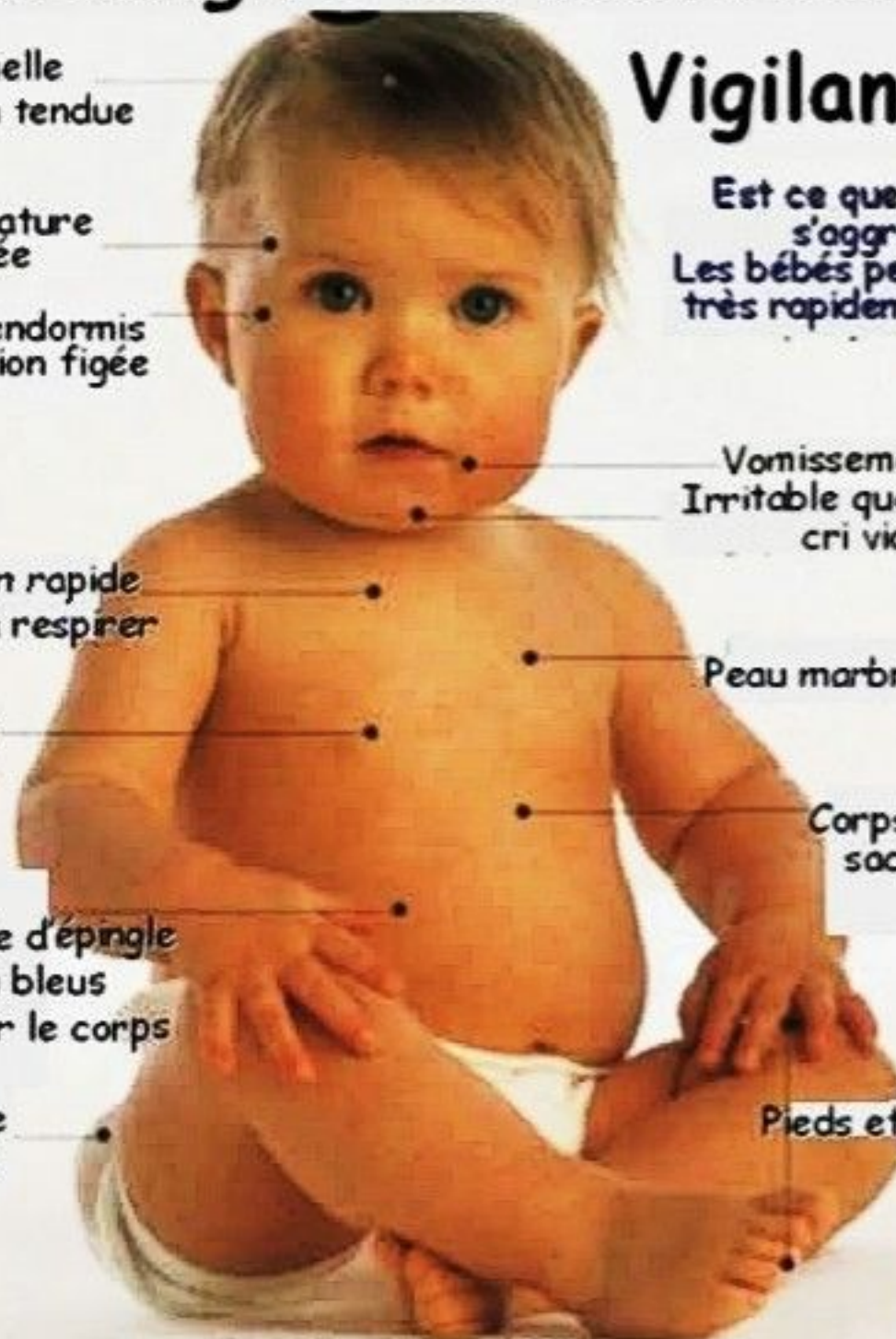
Frissons
intenses

Corps raide, avec des mouvements
saccadés ou au contraire mou
et sans vie

Éruption en tête d'épingle
Marques ou bleus
n'importe où sur le corps

Diarrhée
parfois

Pieds et mains froids



Tonic phase



Clonic phase

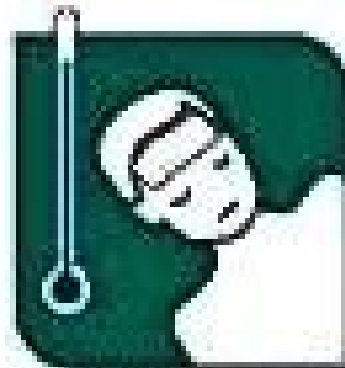


FEBRILE SEIZURE

Symptôme de la méningite chez l'enfant et l'adulte



Vomissements



Fièvre



Céphalées



Photophobie



Raideur de
la nuque



Etat de
sommolence,
de torpeur



Douleurs
articulaires



Tétanie

**Tous ces symptômes ne sont pas
forcément présents simultanément**